

STRAW+10 分期

你的阶段判断

围绝经早期（变化开始期） 很可能

- ☐ 生育晚期 · 变化萌芽
- ☒ **围绝经早期** · 变化开始
- ☐ 围绝经晚期 · 变化加速
- ☐ 绝经早期 · 过渡完成
- ☐ 绝经稳定期 · 新的稳定

你很可能在这里

你的月经仍会来，但周期前后相差已超过一周。

你的症状负担

血管舒缩 轻度

血管舒缩症状：1/4
潮热的频率与严重程度

情绪认知 中度

情绪与认知：3/8
焦虑紧张和睡眠相关变化

泌尿生殖 轻度

泌尿生殖：1/6
阴道干涩和反复泌尿生殖感染线索

躯体症状 重度

躯体症状：3/4
关节僵硬或疼痛等身体变化

感觉异常 重度

感觉异常：3/4
怕冷、怕热或忽冷忽热等温度敏感变化

综合：中度

你的身体正在经历什么

雌激素显著减退型 ★★☆☆ · 中度吻合

你目前的症状组合，尤其是睡眠变浅、关节僵硬、潮热，与「雌激素显著减退型」的特征中度吻合（★★☆☆）。雌激素水平明显降低，出现潮热、阴道干涩等典型症状。这种变化模式在晚期过渡至早期绝经后（STRAW -1 至 +1）阶段最为常见。

这个阶段的标志是月经周期开始波动，前后相差一周以上，或有时变短、有时变长。背后通常是卵巢对脑垂体信号的响应变得不稳定，排卵不如从前规律，孕酮水平更容易不足。

另外，既往早发性卵巢功能不全提示卵巢功能更早出现衰退，长期低雌激素状态会影响骨骼和心血管健康。

了解你的变化

雌激素持续偏低会影响体温调节、泌尿生殖组织、骨密度和睡眠质量。

建议与下一步

01 · 日常管理

感觉异常

怕冷、怕热或忽冷忽热等温度敏感变化，可能和围绝经期激素波动、睡眠压力状态或甲状腺相关因素共同有关。

下一步

- 记录怕冷、怕热或忽冷忽热出现的时间、环境和持续多久
- 用分层衣物、透气寝具和室温调节减少突然冷热变化带来的不适
- 如果同时有心慌、体重明显变化或持续疲劳，下次就诊时可以和医生一并讨论甲状腺功能

02 · 日常管理

情绪与心理调适

激素波动会影响情绪调节，这不是你的错，也不是“想太多”。

下一步

- 每天 20–30 分钟中等强度运动，对情绪改善有研究支持
- 可以试试正念冥想或深呼吸，哪怕每天 5 分钟也有帮助
- 保持社交联系，和信任的人聊聊你的感受

03 · 日常管理

改善睡眠

睡眠问题在围绝经期很普遍，和激素变化以及压力恢复都有关系。

下一步

- 尽量固定入睡和起床时间，周末也尽量保持接近
- 睡前 1 小时减少屏幕使用，用阅读或轻音乐替代
- 午后减少咖啡因，睡前避免大量饮水

04 · 了解更多

激素水平

如果你想更清楚地了解身体正在经历的变化，可以在方便时做一次性激素六项和 AMH 检查。性激素六项反映当前的激素状态，AMH 帮助了解卵巢的储备情况。

下一步

- 性激素六项：建议在月经第 2–5 天空腹抽血
- AMH（抗缪勒管激素）：不受月经周期影响，任何时间都可以查

05 · 了解更多

复查时机

围绝经期的变化常常不是一次检查就能完全说明，结合月经记录和症状变化复查，会更容易看清趋势。

下一步

- 连续记录 2–3 个月月经、潮热、睡眠和情绪变化
- 如果症状明显加重或出现异常出血，提前就诊沟通

06 · 了解更多

就诊沟通准备

带着结构化信息去看医生，可以减少遗漏，也更方便医生判断是否需要进一步检查或干预。

下一步

- 就诊前整理最近 3 个月月经日期、出血量和症状变化
- 带上既往体检、妇科超声、甲状腺或激素相关检查结果

▼ 关于本评估

本评估基于 STRAW+10 生殖衰老分期标准，并参考 MRS、Peri-SS 等更年期症状量表框架，

将月经线索、症状严重程度和风险信号综合成健康建议。结果不能替代医学诊断，建议作为就诊沟通参考。

BMI：19.2（正常）。BMI 会影响雌激素代谢和胰岛素敏感性，已纳入本次分析。

联系方式：123****8901

▼ 科学依据

本评估基于 STRAW+10 国际生殖衰老分期系统和经验证的围绝经期症状量表（MRS/Peri-SS/GCS）设计，综合 42篇临床研究文献，仅供健康参考，不构成医疗诊断。

- [R1] STRAW+10 分期系统 (Harlow 2012) [↗](#)
- [R4] MRS 方法学综述 (Heinemann 2004) [↗](#)
- [R39] MRS 治疗阈值研究 (Blümel 2018) [↗](#)
- [R40] Peri-SS 四维度症状量表验证 (2025) [↗](#)
- [R41] PCORI 患者报告数据展示研究 (2020) [↗](#)
- [R42] AI 置信度可视化模式 [↗](#)

▼ 免责声明与报告操作

了解自己的身体是迈向健康的第一步。本工具基于 STRAW+10 国际生殖衰老分期系统 (Harlow et al., 2012)、更年期评定量表 MRS (Heinemann et al., 2003) 和 Greene 更年期量表 (Greene, 1976) 的条目框架设计，综合 42 篇经过同行评审的临床研究文献。评估结果用于帮助理解阶段、症状负担和可能的身体变化线索，不构成疾病诊断或治疗建议。如有任何健康疑虑，请咨询妇科或内分泌科医生。

报告编号：RPT-20260601-KV83

返回第 1 页修改

返回第 2 页修改

返回第 3 页修改